

cancer screening practices and current status of vaccination implementation in Russian Federation, the Western countries of the former Soviet Union, Caucasus region and Central Asia //Vaccine.-2013.-Vol.31, №7.-P.46–58.

ТҰЖЫРЫМ

Р.О.Ботабекова, А.Ж.Жылкайдарова, М.Р.Кайрбаев

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Жатыр мойыны скринингінің әлемдік тәжірибесі

Тұжырым. Globocan 2012 бойынша жатыр мойыны қатерлі ісігі онкологиялық аурулармен ауыратын әйелдер арасында төртінші орынды алса, барлық қатерлі ісіктердің ішінде жетінші орынды құрайды. Тек 2012 жылы ғана жатыр мойыны қатерлі ісігінен 528,000 жаңа жағдай анықталды. Дамушы мемлекеттерде жатыр мойыны қатерлі ісігімен 85% астам жағдай кездеседі, соның үштен бірі барлық әйелдерде аурудың асқынған сатысында анықталады. Дүние жүзілік аурушандылық пен өлім көрсеткіші әрдайым бүгінгі күндегідей болған жоқ. Қазіргі таңда жатыр мойыны қатерлі ісігін ерте сатысында анықтауға арналған скринингтік бағдарлама жұмыс жасауда. Дамушы мемлекеттерде бұл бағдарлама көп жағдайда арнайы топтардан цитологиялық зерттеу негізінде жасалса, дамыған мемлекеттерде адам папиллома вирусы жоғары қауіпі бар ПАП және ДНК тестімен тексеріледі, ресурстары шектеулі мемлекеттерде жатыр мойнын сірке қышқылы арқылы визуальды әдіспен бағалайды. Қазіргі таңда қолданатын скринингтің тарихы көп. Бұл мақалада XX ғасырдың басындағы медициналық аурулардың дамуына, 1960 жылғы скрининг бағдарламасының пайда болуына, алдын алу шараларының әдістеріне, сонымен қатар Қазақстандағы скринингтік көмектің дамуына сараптама жүргізіледі.

Түйінді сөздер: жатыр мойыны қатерлі ісігі, скрининг, адам папиллома вирусы.

Р.О.Ботабекова, А.Ж.Жылкайдарова, М.Р.Кайрбаев

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Мировой опыт скрининга рака шейки матки

Рак шейки матки относится к социально значимым проблемам современного мира, является одной из лидирующей причины смертности женщин в самом активном возрасте, в развивающихся странах. Злокачественное новообразование шейки матки по данным Globocan 2012 занимает четвертое место среди онкологических заболеваний у женщин и седьмое место среди всех злокачественных новообразований. Только за 2012 год было выявлено 528,000 новых случаев рака шейки матки. В более чем в 85% случаев рак шейки матки выявляется в развивающихся странах, где треть всех женщин выявляется в запущенной стадии заболевания. Регионами с высокими показателями заболеваемости раком шейки матки, где обнаружение в более чем 30 случаев на 100,000 населения являются страны Восточной Африки (42,7), Южная Африка (31,5) и страны Латинской Америки (20,0). А регионами с самыми низкими показателями заболеваемости являются страны Северной Америки (10,2), Западной Европы (8,0), Австралия (5,5), Новая Зеландия (5,5), страны Западной Азии (4,4). Только за 2012 год, по данным Globocan 2012 смертность от рака шейки матки составила 266,000 случаев, что составляет 7,5 % от всех случаев смерти женщин от рака. Почти 9 из 10 случаев смерти приходится на долю менее развитых стран, что составляет 87 % от всех случаев. Самая высокая смертность от данного заболевания, где показатели составляют более 20 на 100,000 населения в странах Восточной Африки (27,6). Мировая статистика заболеваемости и смертности, которую мы имеем сейчас, не всегда была таковой. Показатели заболеваемости раком шейки матки до введения скрининговой программы в 60-ые и 70-ые годы прошлого столетия показывают, что заболеваемость в большей части Европы, Северной Америке и Японии была идентична

той заболеваемости, что мы имеем на сегодняшний день в развивающихся странах. [1]. Например, 38,0 на 100,000 населения в США, 37,8 в Гамбурге, Германия, 28,3 на 100,000 населения в Дании и 22,1 на 100,000 населения в Японии. [2,3]. Показатели нынешней статистики являются результатом хорошей работы скрининговой программы.

Рак шейки матки является тем заболеванием, которое можно предупредить. На сегодняшний день существует скрининговая программа для раннего выявления рака шейки матки. Данная программа в развивающихся странах в большинстве случаев основана на цитологическом исследовании для отобранной группы, в развитых странах ПАП тест сопровождается ДНК тестом на ВПЧ высокого риска. Мета-анализы и систематические обзоры, проведенные агентством по охране здоровья США (U.S.AgencyforHealthCarePolicyandResearch), показали, что конвенционный ПАП тест обладает чувствительностью в 51% и специфичность составляет 98% в обнаружении предраковой патологии [4]

В условиях ограниченных ресурсов изучено применение VIA - визуальной оценки с применением уксусной кислоты. Этот метод показал себя, как простой и дешевый, экономически выгодный метод детекции в менее развитых странах. Исследования, включающие в себя кольпоскопию и биопсию, в дополнение к VIA определили, что чувствительность VIA в выявлении поражения шейки матки высокого класса почти равносильна как при использовании цитологического скрининга [5].

Существует целая история становления того скрининга, который мы имеем на сегодняшний день. Скрининг был определен в США комиссией по хроническим заболеваниям, как процедура для идентификации непризнанных болезней. В 20-х годах прошлого столетия европей-

ские и американские ученые начали работу по контролю заболеваемости раком шейки матки. В 1924 немецкий гинеколог ХансХинсельман создал бинокулярный увеличитель для осмотра шейки матки - кольпоскоп. В 1933 году австралийский гинеколог Уолтер Шиллер открыл применение раствора иодоната (или Люголя) для обнаружения поражения шейки матки. Эти методы исследования активно использовались в Германии, Австрии и Швейцарии в 30-х годах XX века. На сегодняшний день остается популярной комбинация кольпоскопии и пробы Шиллера, которая в нашей стране начала применяться в последнюю декаду XX века.

Джордж Папаниколау совместно с патоморфологом Гербертом Траутом в 1941 году опубликовали первую работу, описывающую технику окраски мазков из шейки матки, что стало поворотным моментом в истории становления цитологического скрининга и отбросило вперед ученых в изучении рака шейки матки[6]. Объединение таких методов, как кольпоскопия, проба Шиллера и теста Папаниколау гинекологическое общество признало как неинвазивный и дешевый методы обнаружения рака шейки матки. В дальнейшем это стало отправной точкой создания скрининговой программы выявления рака шейки матки в европейских странах и в Америке. Первая национальная скрининговая программа была введена в 1960-х годах в США. Панамериканская организация здравоохранения (РАНО) охарактеризовала данную болезнь как серьезную, но контролируемую проблему здравоохранения, в которой главным решением является внедрение скрининга. До 1980 года ПАП тест был введен как часть регулярной проверки, но не был определен возраст исследуемых женщин, что было исправлено уже в 1980 году.

В 60-х годах XX века появилось мнение о том, что развитие рака шейки матки тесно связано с активностью сексуальной жизни. В это же время развилась теория о вирусном происхождении данной патологии. В 1968 году появилось предположение о том, что рак шейки матки вызывается вирусом простого герпеса, данная гипотеза существовала вплоть до 1980 года, несмотря на неспособность продемонстрировать вирусную ДНК в цитозолиопахуоли[7,8]. Позже, обнаружение того факта, что койлоциты в опухолевой ткани были идентичны ткани пораженной кондиломами, способствовало открытию главного этиологического фактора РШМ-вируса папилломы человека. Так же этому способствовало развитие вирусологии как науки. С помощью вирусологических методов были выявлены различные типы ВПЧ. В 1980 году было сделано большое открытие профессором Харальдом цурХаузенем 16 и 18 типов ВПЧ как высокого онкогенного риска методом двойного гибридного захвата и ПЦР, что принесло исследователю в 2008 Нобелевскую премию [9,10]. Благодаря данному открытию было положено начало в организации первичной профилактики рака шейки матки, то есть созданию вакцин против вируса папилломы человека высокого онкогенного риска. В СССР впервые цитологическое исследование по Папаниколау было проведено профессором Серебровым С.И. в 1953 году. С 1960 года начали повсеместно функционировать цитологические лаборатории в Москве и Ленинграде. Начиная с 1964 года стали функционировать кабинеты профилактических осмотров, но не было успешной орга-

низации данной программы. С 1977 г. в СССР началось формирование централизованных цитологических лабораторий, с включением цитологического скрининга в систему ежегодных массовых профилактических осмотров в женских консультациях и смотровых кабинетах, однако с преимущественным использованием окраски цитологических мазков методом Романовского-Гимзе. К сожалению, не была создана правильная организация данной программы, что показала недостаточную эффективность, так как не было должного полного охвата населения.

С 1991 года после политических и экономических изменений и с образованием нового государства в Казахстане количество профилактических осмотров и их эффективность существенно снизилась.

В Казахстане рак шейки матки среди женского населения занимает II место после рака молочной железы. Злокачественная опухоль шейки матки в Казахстане ежедневно уносит 2 женские жизни в самом активном возрасте, нанося колоссальный урон всему государству.

С 2005 года в нашей стране начали проводиться профилактические осмотры в женских кабинетах. В 2008 году был издан приказ МЗ РК № 607 «О совершенствовании профилактических осмотров отдельных категорий взрослого населения», в 2009г был издан приказ №685 «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения» с изменениями и дополнениями №361 от 29.12.2014г. И, начиная с 2008 года, существует национальная программа скрининга рака шейки матки с использованием ПАП теста с оценкой по классификации Бетезда[11]. Исследование проводится женщинам от 30 до 60 лет с интервалом в 5 лет. Внедрение данной программы началось поэтапно, начиная с обучения специалистов, организации женских кабинетов, оснащения кольпоскопами кабинетов женских консультации[12]. С 2011 года активно начала внедряться жидкостная цитология, которая имеет ряд преимуществ по отношению к традиционному методу. Данный метод исследования является быстрым и легким методом получения образца, также имеет большую чувствительность в отношении патологии легкой и тяжелой степени. На сегодняшний день завершен первый раунд цервикального скрининга и обследовано более 3 миллионов женщин.

В данный момент Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии и Департаментом организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития ведется активная работа по улучшению качества скрининга, разработаны стандарты качества, проводится организационно-методическая работа, ведется разработка национальных руководств и инструкции по организации скрининговых программ. Также проводится первичная профилактика рака шейки матки, вакцинация девочек подростков в возрасте 11-13 лет в 4 регионах Казахстана. В перспективе расширение целевых групп для скрининга рака шейки матки и также полный охват вакцинации против вируса папилломы человека высокого риска.

Скрининг рака шейки матки является неотъемлемой частью Национальной скрининговой программы, которая является одной из ведущих стратегий охраны здоровья населения Казахстана, входит в программные вопросы развития здравоохранения и финансируется за счет республиканского бюджета.